



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فايزة محمد السيد طلبه

العنوان : 43 ش خلاف - خرطة

الشيخ مبارك مصر القديمة -
القاهرة

الحي / المدينة : مصر القديمة

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم البطاقة : 25005222601343 رقم التليفون : 01006116498

العمر (تاريخ الميلاد) : 22-05-1950 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فائزة محمد السيد طلبة National ID: 25005222601343	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

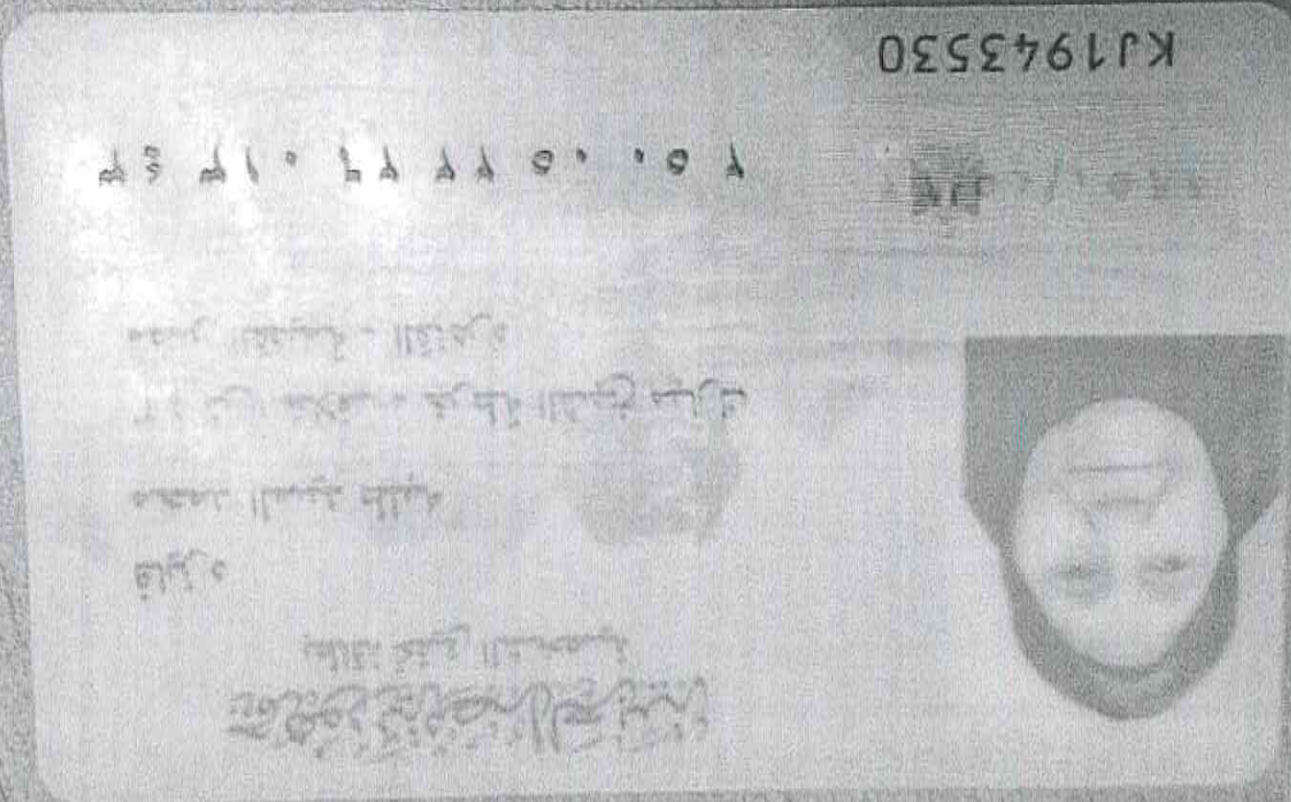
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



KJ1943530

১০.০৪.১৯৮০

নাম: সুজাতা বেগম
পিতার নাম: মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
মাতার নাম: সুজাতা বেগম
তারিখ: ১০.০৪.১৯৮০
স্বাক্ষর: সুজাতা বেগম

Patient Name	فايزة محمد السيد	Case No.	361814
Sex/Age	Female 76 Y	Patient No.	26564
Registered Date	01/9/2026 09:12:07 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	21/9/2026 04:24:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/9/2026 12:25:43 PM	Pathology No.	SR-1006/26

Pathology Report

Clinical Data: MRI showing distended endometrial cavity containing blood with multifocal irregular polypoid endometrial soft tissue lesions involving the uterine body & fundus, highly suspicious for endometrial carcinoma.

Nature of specimen: Referred block (Dilation & Curettage).

Gross Examination

One referred block labelled by (2047-2026).

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench-Mark ULTRA system for; Vimentin, P53 clone (Bp53-11) & ER clone (SP1).

Microscopic Examination

Histopathological examination reveals pieces of tumor formed of slit-like spaces and fused glands lined by malignant epithelial cells showing moderate anaplasia. Areas of necrosis are seen.

** IPT (Controls show appropriate reactivity):

- Vimentin: Negative in tumor cells.
- ER: Negative in tumor cells.
- P53: Mutant (Diffuse strong positive staining in tumor cells).

Diagnosis

Uterine mass, Referred block (Dilation & Curettage):

- Invasive poorly differentiated adenocarcinoma with extensive necrosis.
- Further immunophenotyping for (PAX-8, P16, CK7, CEA, etc....) is recommended to verify the nature o cells.

Signature

IHC



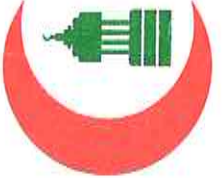
غرفة رقم (4) - الدور 1^و - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairn, Egypt

Patient Name	فايزة محمد السيد	Case No.	361814
Sex/Age	Female 76 Y	Patient No.	26564
Registered Date	01/9/2026 09:12:07 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	21/9/2026 04:24:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/9/2026 12:25:43 PM	Pathology No.	SR-1006/26

Prof. Dr. Maha Guimej, MD, PhD.



خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة 5 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

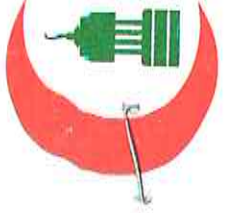


تابع: فائزة محمد السيد

Conclusion:

- Distended endometrial cavity containing hemorrhagic fluid/blood products (hematometra) with multifocal irregular enhancing polypoid endometrial soft tissue lesions involving the uterine body and fundus, associated with focal indistinctness of the junctional zone, highly suspicious for endometrial carcinoma with probable superficial myometrial invasion. Associated heterogeneous signal within the cervical canal likely represent retained secretions; however, correlation with histopathology is advised to exclude lower uterine segment/cervical canal involvement.
- No MRI evidence of parametrial extension, pelvic lymphadenopathy, or distant pelvic metastatic disease.
- Incidental benign-appearing 2.7 cm simple right adnexal cyst.
- Cholelithiasis/calicular gall bladder with no MRI evidence of acute cholecystitis.

Dr. Ramy El-Toukhy, MD



Patient Name: **فايزة محمد السيد**

Study Date: 21/07/2026 11:32:55 AM

M.R.I. OF THE ABDOMEN & PELVIS

Technique:

- Multiple pulse sequences in different planes before and after IV contrast.

Findings:

- The uterus measures about 5X5.5X8cm showing large retained bloody secretions within its body and fundus and shows multifocal ill-defined polypoidal soft tissue thickening/enhancement with multifocal ill definition of junctional zone at body and fundus. No parametrial lesions. Associated heterogeneous contents within the cervical canal.
- RIGHT adnexal benign looking thin walled unilocular non-enhancing cyst about 2.2X2.6X2.7cm.



- No ascites, free pelvic collections or pathological lymphadenopathy.
- Calcular gall bladder harboring variable sized stones, largest about 1.7cm and smallest around 5mm. No significant mural thickening or associated collections.
- Liver is of average size and regular outline with no hepatic focal lesions or dilated biliary radicles. Spleen, kidneys, adrenal glands and pancreas as well as urinary bladder (its wall measures 4mm thick circumferentially i.e. equivocal mild thickening) are within normal.
- The stomach and scanned bowel loops are within normal.

P.T.O

KJ1943530

১০.০৭.১৯৮০

নাম:
 পিতা:
 মাতা:
 জাতি:

স্বাক্ষর:
 তারিখ:



Patient Name	فايزة محمد السيد	Case No.	361814
Sex/Age	Female 76 Y	Patient No.	26564
Registered Date	01/9/2026 09:12:07 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	21/9/2026 04:24:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/9/2026 12:25:43 PM	Pathology No.	SR-1006/26

Pathology Report

Clinical Data: MRI showing distended endometrial cavity containing blood with multifocal irregular polypoid endometrial soft tissue lesions involving the uterine body & fundus, highly suspicious for endometrial carcinoma.

Nature of specimen: Referred block (Dilation & Curettage).

Gross Examination

One referred block labelled by (2047-2026).

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench-Mark ULTRA system for; Vimentin, P53 clone (Bp53-11) & ER clone (SP1).

Microscopic Examination

Histopathological examination reveals pieces of tumor formed of slit-like spaces and fused glands lined by malignant epithelial cells showing moderate anaplasia. Areas of necrosis are seen.

** IPT (Controls show appropriate reactivity):

- Vimentin: Negative in tumor cells.
- ER: Negative in tumor cells.
- P53: Mutant (Diffuse strong positive staining in tumor cells).

Diagnosis

Uterine mass, Referred block (Dilation & Curettage):

- Invasive poorly differentiated adenocarcinoma with extensive necrosis.
- Further immunophenotyping for (PAX-8, P16, CK7, CEA, etc....) is recommended to verify the nature o cells.

Signature

IHC



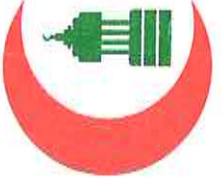
غرفة رقم (4) - الدور 1^و - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - معمل الباثولوجي - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mivr El Qadema - Cairn, Egypt

Patient Name	فايزة محمد السيد	Case No.	361814
Sex/Age	Female 76 Y	Patient No.	26564
Registered Date	01/9/2026 09:12:07 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	21/9/2026 04:24:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/9/2026 12:25:43 PM	Pathology No.	SR-1006/26

Prof. Dr. Maha Guimej, MD, PhD.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة 5 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

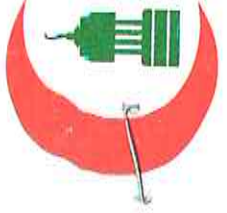


تابع: فائزة محمد السيد

Conclusion:

- Distended endometrial cavity containing hemorrhagic fluid/blood products (hematometra) with multifocal irregular enhancing polypoid endometrial soft tissue lesions involving the uterine body and fundus, associated with focal indistinctness of the junctional zone, highly suspicious for endometrial carcinoma with probable superficial myometrial invasion. Associated heterogeneous signal within the cervical canal likely represent retained secretions; however, correlation with histopathology is advised to exclude lower uterine segment/cervical canal involvement.
- No MRI evidence of parametrial extension, pelvic lymphadenopathy, or distant pelvic metastatic disease.
- Incidental benign-appearing 2.7 cm simple right adnexal cyst.
- Cholelithiasis/calicular gall bladder with no MRI evidence of acute cholecystitis.

Dr. Ramy El-Toukhy, MD



Patient Name: **فايزة محمد السيد**

Study Date: 21/07/2026 11:32:55 AM

M.R.I. OF THE ABDOMEN & PELVIS

Technique:

- Multiple pulse sequences in different planes before and after IV contrast.

Findings:

- The uterus measures about 5X5.5X8cm showing large retained bloody secretions within its body and fundus and shows multifocal ill-defined polypoidal soft tissue thickening/enhancement with multifocal ill definition of junctional zone at body and fundus. No parametrial lesions. Associated heterogeneous contents within the cervical canal.
- RIGHT adnexal benign looking thin walled unilocular non-enhancing cyst about 2.2X2.6X2.7cm.



- No ascites, free pelvic collections or pathological lymphadenopathy.
- Calcular gall bladder harboring variable sized stones, largest about 1.7cm and smallest around 5mm. No significant mural thickening or associated collections.
- Liver is of average size and regular outline with no hepatic focal lesions or dilated biliary radicles. Spleen, kidneys, adrenal glands and pancreas as well as urinary bladder (its wall measures 4mm thick circumferentially i.e. equivocal mild thickening) are within normal.
- The stomach and scanned bowel loops are within normal.

P.T.O